

CAPÍTULO 14.15

Polimiositis y Dermatomiositis

PERFIL EUNACOM 1.11.1.020

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las miopatías inflamatorias idiopáticas son un grupo de enfermedades autoinmunes sistémicas que tienen como blanco principal el músculo estriado esquelético (**Miositis**). Dentro de este grupo, las dos entidades más representativas son la **Polimiositis (PM)** y la **Dermatomiositis (DM)**, diferenciándose esta última por presentar, además, un compromiso cutáneo característico.

Cuadro Clínico General

La manifestación cardinal de estas patologías es la **debilidad muscular**. Es fundamental distinguir el patrón de debilidad para diferenciarlo de otras patologías neurológicas.

- **Distribución:** La debilidad es de predominio **proximal** y simétrica. Afecta principalmente las cinturas escapular y pelviana.
- **Funcionalidad:** El paciente relata dificultad para peinarse, levantar los brazos sobre la cabeza, subir escaleras o levantarse de una silla sin apoyo.
- **Diferencia clave:** A diferencia de las neuropatías (que suelen ser distales), las miopatías son proximales.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, ante un paciente con debilidad para subir escaleras o peinarse, siempre piensa en una miopatía. Si además mencionan lesiones en la piel, el diagnóstico es **Dermatomiositis**.

Manifestaciones Cutáneas (Dermatomiositis)

La Dermatomiositis presenta un compromiso cutáneo que puede preceder, coincidir o seguir a la debilidad muscular. Existen tres signos clásicos que deben ser identificados:

- **Rash Heliotropo:** Es un eritema de color lila o violáceo (similar a la flor del heliotropo) que aparece alrededor de los ojos. Afecta con mayor frecuencia los **párpados superiores**, pero puede comprometer los inferiores y suele acompañarse de edema periorbitario.
- **Rash en Manto (Signo del Chal):** Eritema macular que afecta el pecho (escote en V), los hombros y la parte alta de la espalda.
- **Pápulas de Gottron:** Son lesiones eritematosas o violáceas, a veces descamativas, que aparecen sobre los **nudillos** (articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas tanto proximales como distales).

TABLA 14.15.1: HALLAZGO CUTÁNEO VS LOCALIZACIÓN TÍPICA

HALLAZGO CUTÁNEO	LOCALIZACIÓN TÍPICA	CARACTERÍSTICAS
Rash Heliotropo	Párpados superiores e inferiores	Color violáceo, puede tener edema.
Pápulas de Gottron	Nudillos (MCF, IFP, IFD)	Patognomónico de Dermatomiositis.
Signo del Chal	Hombros y espalda alta	Rash eritematoso difuso.

Compromiso Extramuscular

Aunque el músculo es el protagonista, estas enfermedades son sistémicas:

- **Pulmonar:** La **Fibrosis Pulmonar** (enfermedad intersticial) es una complicación grave. Se asocia fuertemente al **Síndrome Antisintetasa**.
- **Esfágico:** Puede presentarse **disfagia** por afectación de los músculos del tercio superior del esófago (músculo estriado).
- **Cardíaco:** Se puede afectar el músculo cardíaco (miocarditis o arritmias).

NOTA CLÍNICA

La disfagia también es muy característica de la **Esclerodermia**, pero en el caso de las miositis, se debe a la inflamación directa de la musculatura estriada faríngea y esofágica superior.

Diagnóstico y Exámenes de Apoyo

El diagnóstico se basa en la sospecha clínica (debilidad proximal) apoyada por exámenes de laboratorio e imágenes.

- **Enzimas Musculares:** La **Creatina Fosfoquinasa (CK o CPK)** es el marcador de daño muscular más importante. Suele estar significativamente elevada en fases activas de la enfermedad.
- **Electromiografía (EMG):** Muestra una conducción nerviosa normal (descartando neuropatía) pero con una respuesta muscular alterada (potenciales miopáticos).
- **Resonancia Magnética (RM):** Es útil para detectar edema muscular e inflamación, ayudando a elegir el mejor sitio para una biopsia.
- **Biopsia Muscular:** Es el examen definitivo. Muestra infiltrado inflamatorio y daño en las fibras musculares.
- **Anticuerpos:**
 - **Anti-Jo-1:** El más conocido. Se asocia al **Síndrome Antisintetasa** (Miositis + Fibrosis Pulmonar + manos de mecánico + fiebre).
 - **Anti-Mi-2:** Muy específico de Dermatomiositis, suele tener buen pronóstico.
 - **Anti-SRP:** Asociado a polimiositis grave y afectación cardíaca.

Asociación con Cáncer (Fenómeno Paraneoplásico)

Un aspecto fundamental en el manejo de la **Dermatomiositis** (y en menor medida la Polimiositis) es su asociación con neoplasias malignas.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En todo paciente adulto con diagnóstico de Dermatomiositis, es **obligatorio** realizar un tamizaje de cáncer (pulmón, ovario, mama, colon, etc.), ya que la enfermedad puede ser una manifestación paraneoplásica.

Variantes Especiales: Dermatomiositis Amiopática

Existe una variante denominada **Dermatomiositis Amiopática**. En este caso, el paciente presenta todas las lesiones cutáneas características (Heliotropo, Gottron), pero **no tiene debilidad muscular** y sus niveles de CK son normales. El diagnóstico es clínico por la especificidad de las lesiones cutáneas.

Tratamiento

El manejo debe ser liderado por un especialista (reumatólogo), pero el médico general debe conocer las bases:

- **Corticoides:** Son la primera línea de tratamiento (Prednisona a dosis altas). Suelen tener una buena respuesta inicial.
- **Ahorraadores de Corticoides:** En casos crónicos o resistentes, se utilizan inmunosupresores como Metotrexato o Azatioprina.
- **Manejo de la Neoplasia:** Si es paraneoplásica, el tratamiento del cáncer de base suele mejorar la sintomatología muscular.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Resumen para el EUNACOM: - Debilidad proximal + CK elevada = Miopatía. - Si tiene Rash Heliotropo/Gottron = Dermatomiositis. - Si tiene Anti-Jo-1 = Riesgo de Fibrosis Pulmonar. - ¡Siempre buscar cáncer en Dermatomiositis!

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente con debilidad proximal, CK elevada y rash violáceo en párpados con edema. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Polimiositis y Dermatomiositis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Polimiositis: debilidad proximal + CK elevada; dermatomiositis agrega compromiso cutáneo
- Tres rashes de dermatomiositis: heliotropo (párpados), en manto (pecho/hombros/espalda), pápulas de Gottron (nudillos)
- Anti-Jo1 se asocia al síndrome antisintetasa (dermatomiositis + fibrosis pulmonar)
- Siempre buscar cáncer en dermatomiositis (manifestación paraneoplásica)
- Diagnóstico: clínica + CK elevada; biopsia muscular si hay duda
- Tratamiento: corticoides con buena respuesta

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (POLIMIOSITIS Y DERMATOMIOSITIS)**PREGUNTA 1**

Paciente con debilidad proximal, CK elevada y rash violáceo en párpados con edema. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Polimiositis
- B)** Dermatomiositis
- C)** Miastenia gravis
- D)** Lupus eritematoso sistémico
- E)** Esclerodermia

PREGUNTA 2

Paciente con dermatomiositis presenta fibrosis pulmonar y anticuerpos anti-Jo1 positivos. ¿Cómo se denomina este cuadro?

- A)** Síndrome de Sjögren
- B)** Enfermedad mixta del tejido conectivo
- C)** Síndrome antisintetasa
- D)** Síndrome de CREST
- E)** Síndrome antifosfolípido

PREGUNTA 3

¿Qué estudio adicional siempre se debe realizar en un paciente diagnosticado con dermatomiositis?

- A)** Densitometría ósea
- B)** Búsqueda de cáncer oculto
- C)** Estudio de líquido articular
- D)** Angiografía pulmonar
- E)** Ecocardiograma

RESUMEN: POLIMIOSITIS Y DERMATOMIOSITIS

La polimiositis y dermatomiositis son miopatías autoinmunes. La polimiositis cursa con debilidad muscular de predominio proximal (a diferencia de neuropatías que son distales). La dermatomiositis agrega compromiso cutáneo con tres rashes característicos: heliotropo (párpados superiores, color lila/violáceo con edema), rash en manto (pecho, hombros, espalda) y pápulas de Gottron (sobre nudillos). El diagnóstico se basa en debilidad proximal + CK elevada + compromiso cutáneo (dermatomiositis). Si hay duda: biopsia muscular, electromiografía o RMN. El anticuerpo anti-Jo1 se asocia al síndrome antisintetasa (dermatomiositis + fibrosis pulmonar). La dermatomiositis amiopática tiene rash sin debilidad ni CK elevada. Siempre buscar cáncer en dermatomiositis (manifestación paraneoplásica frecuente). El tratamiento es con corticoides, con ahorradores de corticoides si es necesario.